CÓDIGO VASCULAR RD

2026 FLUTER SUMMIT
Salud Vascular y Terapia Integral



Guía clínica
de consulta rápida

- **Referimiento inmediato**
- **Evaluación el mismo día**
- **Consulta prioritaria**
- **Seguimiento ambulatorio**

HERRAMIENTA MULTIDISCIPLINARIA
para decisiones oportunas y atención integral del paciente vascular

CEREBRO VASCULAR | ISQUEMIA AGUDA | EAP | TVP / EMBOLIA PULMONAR | AORTA | CABEZA Y CUELLO

Salud Vascular y Terapia Integral:
de la prevención al manejo quirúrgico especializado.

FLUTER DOMULL

CÓMO UTILIZAR
CÓDIGO VASCULAR RD

Guía clínica de consulta rápida para decisiones oportunas en urgencias vasculares

Siga 5 pasos para una atención oportuna y segura

1. **RECONOCER**
   Identifique signos y síntomas clave de una urgencia vascular.
2. **CLASIFICAR EL RIESGO**
   Determine la prioridad según la condición clínica del paciente.
3. **ACTUAR**
   Inicie las medidas iniciales y el tratamiento recomendado.
4. **REFERIR**
   Active la ruta vascular y transfiera al centro adecuado sin demora.
5. **DAR SEGUIMIENTO**
   Confirme la evolución y la continuidad de la atención.

NIVELES DE PRIORIDAD CLÍNICA (SEMÁFORO)

Referimiento inmediato	Evaluación el mismo día	Consulta prioritaria	Seguimiento ambulatorio
Condición crítica. Riesgo vital o de pérdida de función.	Condición urgente. Requiere valoración en horas.	Condición estable con riesgo de deterioro.	Condición estable. Manejo ambulatorio según protocolo.
ACCIONE YA	**NO RETRASAR**	**AGENDA PRONTO**	**CONTROLAR**

IDENTIFIQUE EL CÓDIGO CLÍNICO POR LA FRANJA LATERAL

Cada página clínica tiene una franja de color en el borde exterior para identificar rápidamente el código clínico correspondiente.



EJEMPLO:

Cerebrovascular

Si ve esta franja morado, está en el Código Cerebrovascular.

Los colores del **SEMÁFORO** indican la **PRIORIDAD** de atención, no el código.

INFORMACIÓN ESCENCIAL AL REFERIR

Ante cada referencia, incluya estos datos para facilitar la continuidad del cuidado.

HORA DE INICIO	SIGNOS VITALES	HALLAZGOS	ESTUDIOS REALIZADOS	TRATAMIENTO ADMINISTRADO	DATOS DEL MÉDICO REMITENTE
Hora exacta de inicio de síntomas o del evento	PA, FC, FR, T°, $SatO_2$, y glucemia (si disponible).	Hallazgos clínicos relevantes al examen físico.	Laboratorios e imágenes con resultados clave.	Medicamentos, procedimientos y hora de administración.	Nombre, contacto, institución y firma (si aplica).

ANTES DE REFERIR: ACTIVE LA RUTA VASCULAR

Pasos esenciales para estabilizar, comunicar, trasladar y confirmar la capacidad del centro receptor.

1 ESTABILIZAR
- Asegure ABC.
- Controle dolor.
- Oxigene si precisa.
- Acceso venoso.
- Monitoree signos vitales.

2 COMUNICAR
- Contacte al centro receptor.
- Informe condición, prioridad y tiempo estimado.
- Documente la comunicación.

3 TRASLADAR
- Traslado en la mejor condición posible.
- Acompañe con resumen clínico.
- Monitoree durante el traslado.

4 CONFIRMAR
- Confirme capacidad y recursos del centro receptor.
- Reciba confirmación de aceptación.
- Asegure continuidad de la atención.

CÓDIGO CEREBROVASCULAR

Evento Vascular Cerebral Agudo (EVC agudo)

OBJETIVO
Identificar a tiempo, iniciar tratamiento inmediato y reperfundir si está indicado.

MENSAJE CLAVE
Ante la sospecha de EVC agudo, piensa: F.A.S.T. y ACTUE.
Actuar a tiempo protege el cerebro.

EVC: cada minuto cuenta

1. RECONOZCA RÁPIDAMENTE: ¿SOSPECHA EVC?

F FACE (CARA)	**A** ARMS (BRAZOS)	**S** SPEECH (HABLA)	**T** TIME (TIEMPO)
Asimetría facial.	Debilidad en un brazo, no puede elevar ambos.	Dificultad para hablar o entender.	Si presenta alguno de estos signos, actúe de inmediato.

Hora de inicio de los síntomas o última vez que estuvo bien:_____ **Fecha:** __/__/__

2. CLASIFIQUE EL RIESGO INICIAL

- ✓ Déficit neurológico focal de inicio súbito.
- ✓ Tiempo desde el inicio de síntomas conocido o desconocido.
- ✓ Glucemia capilar entre 60-400 mg/dL.

Presión arterial controlable: < 185/110 mmHg.*

- ✓ Sin antecedente de sangrado intracraneal previo.
- ✓ Sin contraindicación mayor para trombólisis o trombectomía.

¿PACIENTE CANDIDATO A REPERFUSIÓN?

Active ruta de reperfusión. La elegibilidad depende de la clínica, el tiempo y la imagen. Consulte criterios específicos.

Manejo médico óptimo. Consulte con neurología para otras opciones.

VENTANAS DE REPERFUSIÓN
(Referenciales - evaluar caso por caso)

TROMBÓLISIS INTRAVENOSA (rt-PA)

- Ideal: dentro de 4.5 horas del inicio de síntomas.
- En pacientes seleccionados, puede considerarse en ventana extendida (4.5-9 horas) o en inicio desconocido, usando criterios de imagen avanzada (RM o TC de perfusión).
- Siempre evaluar riesgos/beneficios y contraindicaciones.

TROMBECTOMÍA MECÁNICA

- Ideal: dentro de 6 horas del inicio.
- En pacientes seleccionados (oclusión de gran vaso y buena imagen), puede ser beneficiosa hasta 24 horas.
- La elegibilidad depende de la clínica, el tiempo, la imagen y el estado del paciente.

NOTA IMPORTANTE
El tiempo transcurrido NO debe retrasar la evaluación especializada.
Ante duda, consulte con neurología y active la ruta vascular.

3. ACTÚE DE INMEDIATO

ESTABILICE
- Asegure ABC.
- Oxígeno si $SatO_2$ < 94%.
- Controle glucemia (140-180 mg/dL).
- Vía IV periférica.
- Monitoree signos vitales.
- Cabeza a 30°.

EVALUE
- Examen neurológico (NIHSS).
- Escala: NIHSS al ingreso y seguimiento.
- ECG de 12 derivaciones.
- Laboratorios básicos: Hemograma, QS, TP/TTPa, creatinina.
- Imagen: TC simple de cráneo sin contraste urgente.

TRATE
- Si es candidato: trombólisis IV ≤ 4.5 h (o 4.5-9 h con criterio de imagen avanzada).
- Si oclusión de gran vaso: activar trombectomía mecánica (≤ 6 h) (puede extenderse hasta 24 h en seleccionados).
- Controle PA, fiebre y glucemia.

DISPONGA
- UCI/Unidad de Ictus si disponible.
- Monitorización neurológica continua.
- Prevenga complicaciones (aspiración, TEP, úlceras).

4. REFIERA SIN DEMORA

COMUNÍQUESE
- Notifique al centro receptor antes del traslado.
- Informe estado del paciente y hora de inicio.
- Confirme disponibilidad para reperfusión.

TRASLADE
- Traslado rápido y seguro.
- Paciente en posición 30°.
- Mantenga vía aérea permeable y oxigenación adecuada.
- Acompañe con resumen clínico.

DOCUMENTE Y ENTREGUE
- Hora de inicio o última vez bien.
- Hallazgos neurológicos (NIHSS).
- Estudios realizados.
- Tratamiento administrado.
- Evolución durante el traslado.
- Datos del médico remitente y contacto.

5. NIVELES DE PRIORIDAD CLÍNICA (SEMÁFORO)

PRIORIDAD ALTA (EMERGENTE)	PRIORIDAD MODERADA (URGENTE)	PRIORIDAD BAJA (SUBAGUDA)	PRIORIDAD ESTABLE (NO URGENTE)
Sospecha de EVC agudo con déficit neurológico significativo o en evolución.	Síntomas leves o estables, paciente potencial para reperfusión; requiere evaluación inmediata.	Síntomas 24 h sin cambios progresivos o datos de deterioro agudo.	Déficit leve y estable, sin progresión.
ACCIÓN INMEDIATA	**EVALUAR SIN RETRASO**	**ATENCIÓN PRONTA**	**CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO**

El semáforo indica la PRIORIDAD de atención, no determina si el paciente es candidato a reperfusión.
La elegibilidad se define por criterios clínicos, de imagen y tiempo.

INFORMACIÓN ESENCIAL AL REFERIR
- ✓ Hora de inicio o última vez que estuvo bien.
- ✓ Signos vitales y glucemia.
- ✓ Hallazgos neurológicos (NIHSS).
- ✓ Estudios realizados (imagen, laboratorios, ECG).
- ✓ Tratamiento administrado (dosis y hora).
- ✓ Evolución durante la atención y el traslado.
- ✓ Datos del médico remitente y teléfono de contacto.

ANTES DE REFERIR: ACTIVE LA RUTA VASCULAR
Pasos esenciales para estabilizar, comunicar, trasladar y confirmar la capacidad del centro receptor.

ESTABILIZAR
- Asegure ABC.
- Controle dolor.
- Oxigene si precisa.
- Monitorice signos vitales.

COMUNICAR
- Contacte al centro receptor.
- Informe condición, prioridad y hora de inicio.
- Documente comunicación.

TRASLADAR
- Traslado rápido y seguro.
- Posición 30°
- Mantenga vía aérea permeable.
- Acompañe con resumen clínico.

CONFIRMAR
- Confirme capacidad de reperfusión del centro receptor.
- Recibo confirmación de aceptación.
- Asegure continuidad de la atención.

CÓDIGO CEREBROVASCULAR
Evento Vascular Cerebral Agudo (EVC agudo)
EVC: cada minuto cuenta

CÓDIGO EXTREMIDAD

ISQUEMIA AGUDA DE LAS EXTREMIDADES.

Algoritmo de acción rápida

OBJETIVO
Identificar rápidamente, iniciar tratamiento inmediato y referir para revascularización urgente para salvar la extremidad.

MENSAJE CLAVE
Los mejores resultados dependen de la rapidez del reconocimiento, la anticoagulación inmediata y la revascularización oportuna.

ACTUAR A TIEMPO SALVA LA EXTREMIDAD

1. RECONOZCA RÁPIDAMENTE: ¿SOSPECHA ISQUEMIA AGUDA?

Sospeche isquemia aguda ante inicio súbito (horas) de:

- **P** Dolor (PAIN) — Dolor súbito, intenso y desproporcionado.
- **P** Palidez (PALLOR) — Piel pálida o moteada.
- **P** Ausencia de pulso (PULSELESSNESS) — Pulso distal ausente o disminuido.
- **P** Parestesia (PARESTHESIA) — Hormigueo o adormecimiento.
- **P** Parálisis (PARALYSIS) — Debilidad o incapacidad para mover.
- **P** Pérdida de sensibilidad (POIKILOTHERMIA) — Extremidad fría o frialdad distal.

Hora de inicio de los síntomas o última vez que estuvo bien: _____ **Fecha:** ___/___/____

2. CLASIFIQUE EL RIESGO

A. CATEGORÍA CLÍNICA (Rutherford)

CATEGORÍA	HALLAZGOS CLÍNICOS	RIESGO DE PÉRDIDA DE EXTREMIDAD
1. VIABLE	• Sin amenaza inmediata. • Función motora y sensitiva íntegras. • Señales arteriales presentes.	BAJO No inmediato
IIA. AMENAZA MARGINAL	• Déficit sensitivo mínimo (dedos). • Déficit motor leve. • Señales arteriales presentes o disminuidas.	MODERADO Horas
IIB. AMENAZA INMEDIATA	• Déficit sensitivo más allá de los dedos. • Déficit motor moderado o severo. • Señales arteriales ausentes o muy disminuidas.	ALTO Horas
III. IRREVERSIBLE	• Anestesia profunda. • Parálisis (rigor). • Extremidad fría, moteada. • Sin señales arteriales.	MUY ALTO Inminente

INICIE ANTICOAGULACIÓN INMEDIATA

(salvo contraindicación)

HEPARINA NO FRACCIONADA (HNF)
- Bolo IV: 80 U/kg (máx. 5,000 U)
- Infusión: 18 U/kg/h
- Ajustar para TTPa 1.5-2.5 veces control

Opción alternativa: ENOXAPARINA
- 1 mg/kg SC cada 12 h
- Última dosis antes de procedimiento: 12 h previas

NOTAS IMPORTANTES
- Obtenga laboratorios básicos inmediatamente.
- Consulte con cirugía vascular / intervencionismo de urgencia.
- Mantenga al paciente en ayuno.

3. ACTÚE DE INMEDIATO

ESTABILICE
- Asegure ABC.
- Oxígeno si $SatO_2$ < 94%.
- Acceso venoso periférico.
- Monitoree signos vitales.
- Cabeza a 30°.

EVALÚE
- Historia breve y hora de inicio.
- Examen vascular completo.
- Evaluar motor, sensibilidad y temperatura.
- Laboratorios: BH, QS, TP/TTPa, creatinina, lactato, CK.

TRATE
- Anticoagule (ver sección 2).
- Analgesia adecuada.
- No eleve la extremidad
- Evite calor local y masajes.

ESTUDIOS
- Ecografía Doppler arterial (inicial).
- Angio-TC o arteriografía según disponibilidad y condición del paciente.

DISPONGA
- UCI/Unidad de cuidados intermedios según condición.
- Monitorización continua.

4. REFIERA SIN DEMORA

COMUNÍQUESE
- Avise al centro receptor antes del traslado.
- Informe: edad, comorbilidades, hora de inicio, categoría clínica, tratamiento iniciado.

TRASLADE
- Traslado rápido y seguro.
- Mantenga anticoagulación en curso.
- Posición de confort.
- Documente hora de salida.

DOCUMENTE Y ENTREGUE
- Hora de inicio o última vez bien.
- Hallazgos del examen vascular.
- Estudios realizados y tratamiento.
- Evolución durante el traslado.
- Datos del médico remitente y contacto.

5. NIVELES DE PRIORIDAD CLÍNICA (SEMÁFORO) *No basado en el tiempo transcurrido*

PRIORIDAD ALTA (EMERGENTE)	PRIORIDAD MODERADA (URGENTE)	PRIORIDAD BAJA (SUBAGUDA)	PRIORIDAD ESTABLE (NO URGENTE)
Amenaza inmediata de pérdida de extremidad o compromiso grave de perfusión.	Riesgo significativo, requiere evaluación y posible revascularización temprana.	Sin amenaza inmediata, pero requiere valoración y planificación oportuna.	Paciente estable posterior a revascularización o en manejo programado.
ACCIÓN INMEDIATA	EVALUAR SIN RETRASO	ATENCIÓN PRONTA	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO

El semáforo indica la PRIORIDAD de atención, no el tiempo transcurrido ni la categoría clínica. La clasificación (I, IIA, IIB, III) determina la urgencia y el riesgo de pérdida de extremidad.

COMUNÍQUESE

- ✓ Hora de inicio o última vez que estuvo bien.
- ✓ Signos vitales y estado hemodinámico.
- ✓ Hallazgos del examen vascular (pulso, temperatura, color, sensibilidad, fuerza).
- ✓ Estudios realizados (Doppler, angio-TC, laboratorios).
- ✓ Tratamiento administrado (anticoagulación, analgésicos, otros).
- ✓ Categoría clínica (Rutherford) y posible Wifi si aplica.
- ✓ Alergias y comorbilidades relevantes.
- ✓ Datos de contacto del médico remitente.

ANTES DE REFERIR: ACTIVE LA RUTA VASCULAR

ESTABILIZAR	COMUNICAR	TRASLADAR	CONFIRMAR
• Asegure ABC. • Controle dolor. • Oxigeno si precisa. • Anticoagule. • Monitoree vitales.	• Contacte al centro receptor. • Informe condición. • Envíe estudios. • Confirme capacidad.	• Traslado rápido y seguro. • Mantenga I.V. activa y anticoagulación. • Paciente en ayuno.	• Confirme capacidad del centro receptor. • Entregue información. • Documente • Acompañe si es posible.

CÓDIGO EXTREMIDAD
ISQUEMIA AGUDA DE LAS EXTREMIDADES. Algoritmo de acción rápida
ACTUAR A TIEMPO SALVA LA EXTREMIDAD

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA

Detección, clasificación y referencia oportuna

CÓDIGO EAP

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA - Detección, clasificación y referencia oportuna

OBJETIVO

Detectar, estratificar y referir oportunamente la enfermedad arterial periférica (EAP) y persona con diabetes en riesgo de ulceración del pie para prevenir complicaciones mayores y amputaciones.

MENSAJE CLAVE

El diagnóstico temprano, el control de factores de riesgo, el cuidado integral del pie y la referencia oportuna al equipo vascular reducen el riesgo de úlceras, infecciones, amputaciones y mortalidad cardiovascular.

1. RECONOZCA: ¿SOSPECHA EAP O PIE DE RIESGO?

SÍNTOMAS DE EAP

- Claudicación intermitente (dolor al caminar que cede con el reposo).
- Dolor en reposo, especialmente
- Extremidades frías, cambios de color (pálida, cianótica) o brillantes.
- Heridas que no cicatrizan, demoran más de 2 semanas.
- Pulsos periféricos disminuidos o ausentes.

FACTORES DE RIESGO PRINCIPALES

- Diabetes *mellitus*
- Tabaquismo actual o previo
- Hipertensión arterial
- Dislipidemia
- Enfermedad renal crónica
- Edad ≥ 50 años
- Antecedente de ECV, cardiopatía o EAP previa
- Sedentarismo / obesidad

PIE DE RIESGO

Presencia de uno o más factores de riesgo + alguna alteración:

- Neuropatía
- Enfermedad vascular periférica
- Deformidad del pie
- Antecedente de úlcera o amputación

Hora de inicio de los síntomas o última vez que estuvo bien: _____ **Fecha:** ___/___/___

2. CLASIFIQUE EL RIESGO

A. CATEGORÍA CLÍNICA (Rutherford)

CATEGORÍA	HALLAZGOS CLÍNICOS	MANEJO GENERAL
0 ASINTOMÁTICA	• Sin síntomas relacionados con EAP.	Control intensivo de factores de riesgo y vigilancia.
1 CLAUDICACIÓN LEVE	• Claudicación no limitante (≥200m).	Ejercicio supervisado y tratamiento médico óptimo.
2 CLAUDICACIÓN MODERADA	• Claudicación limitante (< 200 m).	Ejercicio supervisado. tratamiento médico óptimo y considerar revascularización según caso.
3 DOLOR EN REPOSO	• Dolor en reposo	Evaluación vascular urgente y revascularización según caso.
4 PÉRDIDA TISULAR	• Úlcera o gangrena.	Evaluación vascular urgente y revascularización según caso.

ⓘ El pie diabético con neuropatía y/o EAP debe considerarse SIEMPRE pie de riesgo alto.

B. ISQUEMIA CRÓNICA AMENAZANTE DE LA EXTREMIDAD (CLASIFICACIÓN WIfI)

Evaluar tres componentes y sumar puntaje (0-3 cada uno).

	W HERIDA	I ISQUEMIA (Índice Tobillo-Brazo) o ITB:	fI INFECCIÓN
0	Sin úlcera	• ≥ 0.80	Sin infección
1	Úlcera pequeña (< 1cm)	• 0.60 - 0.79	Infección leve (celulitis < 2 cm sin afectación sistémica)
2	Úlcera profunda (= 1cm), expone tendón o cápsula	• 0.40 - 0.59	Infección moderada celulitis > 2 cm o compromiso de tejidos profundos)
3	Úlcera extensa o gangrena extensa	• ≤ 0.39	Infección severa (respuesta inflamatoria sistémica)

Sume W + I + fI para estratificar el riesgo:

0-2 BAJO | 3-5 MODERADO | 6-8 ALTO | 9 MUY ALTO

3. ACTÚE DE INMEDIATO

ESTABILICE

- Evalúe perfusión, dolor, temperatura y color.
- Oxígeno si $SatO_2$ < 94%.
- Controle glucemia.
- Inicie analgesia adecuada.
- Vacunas según corresponda (tétanos, influenza, neumococo).

EVALÚE

- Historia clínica dirigida y examen físico completo.
- ITB en reposo (brazos y tobillos).
- Si ITB no compresible (>1.40), solicite TOE, PPG o düplex.
- Laboratorios: BH, QS, TOPTT, creatinina, perfil lipídico.
- Documente úlceras (localización, tamaño, profundidad, fotos).

TRATE

- Cuidado local de la herida y descarga de presión.
- Antibiótico según severidad de la infección.
- Control estricto de factores de riesgo.
- Tratamiento médico óptimo (antiagregación, estatina, IECA/ARA II si indicado).
- Revascularización cuando esté indicada.

ESTUDIOS

- ITB / TOE / PPG.
- Ecografía dúplex arterial.
- Angio-TC o arteriografía según disponibilidad y condición del paciente.

DISPONGA

- Valoración por equipo multidisciplinario: vascular, endocrinología, infectología, rehabilitación, podología.
- Plan de seguimiento y educación del paciente y familiares.

4. REFIERA SIN DEMORA

COMUNÍQUESE

- Contacte al centro receptor antes del traslado.
- Informe: categoría clínica / WIfI, heridas, exámenes realizados, tratamiento iniciado y comorbilidades relevantes
- Confirme disponibilidad y logística del traslado.

TRASLADE

- Traslado seguro y preferentemente con la extremidad protegida.
- Mantenga analgesia y antibióticos en curso.
- Posición cómoda.
- Documente hora de salida.

DOCUMENTE Y ENTREGUE

- Historia clínica, estudios y evolución.
- Medicamentos administrados y respuesta.
- Fotografía y mediciones de heridas actuales.
- Datos del médico remitente y contacto.

5. NIVELES DE PRIORIDAD CLÍNICA (SEMÁFORO) *No basado en el tiempo transcurrido*

PRIORIDAD ALTA (EMERGENTE)
Dolor en reposo, úlcera profunda, gangrena, infección severa, isquemia aguda o amenaza inminente de pérdida de extremidad / vida.
ACCIÓN INMEDIATA

PRIORIDAD MODERADA (URGENTE)
Claudicación limitante, úlceras superficiales o infección leve a moderada sin compromiso inmediato crítico.
EVALUAR SIN RETRASO

PRIORIDAD BAJA (SUBAGUDA)
EAP estable sin síntomas limitantes ni heridas activas.
Requiere evaluación y planificación.
ATENCIÓN PRONTA

PRIORIDAD ESTABLE (NO URGENTE)
Paciente controlado, sin nuevos síntomas ni lesiones.
Seguimiento y prevención secundaria.
CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO

ⓘ El semáforo indica la PRIORIDAD de atención, no determina la categoría clínica (Rutherford) ni el puntaje WIfI.

EL TIEMPO PREVIENE AMPUTACIONES

Cada evaluación cuenta.

COMUNÍQUESE

- ✓ Hora de inicio o última vez que estuvo bien (oi aplica dolor agudo).
- ✓ Síntomas, claudicación (distancia en metros) o dolor en reposo.
- ✓ Signos vitales y estado hemodinámico.
- ✓ Categoría clínica (Rutherford) y puntaje WIfI (si aplica).
- ✓ Hallazgos clave del examen vascular y del pie (fotos si es posible).
- ✓ Tratamiento administrado (analgesia, antiagregación).
- ✓ Alergias y medicamentos habituales.
- ✓ Datos del médico remitente y teléfono de contacto.
- ✓ La evaluación oportuna y el manejo integral del pie de riesgo salvan extremidades y vidas.

ANTES DE REFERIR: ACTIVE LA RUTA VASCULAR

ESTABILIZAR →
- Asegure ABC.
- Controle dolor.
- Oxigene si precisa.
- Monitorice signos vitales.

COMUNICAR →
- Contacte al centro receptor.
- Informe categoría clínica (Rutherford) y tratamiento iniciado.

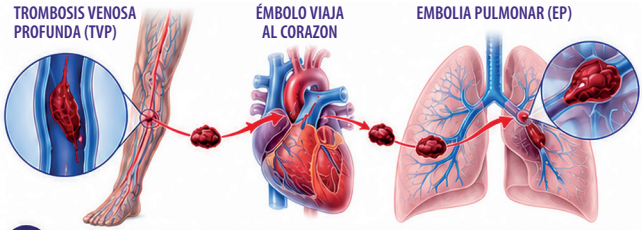
TRASLADAR →
- Traslado seguro y protegido.
- Posición 30°.
- Posición cómoda.
- Mantenga tratamiento en curso.

CONFIRMAR
- Confirme capacidad de recepción.
- Reciba confirmación de capacidad.
- Asegure continuidad de atención.

CÓDIGO TROMBOEMBOLISMO VENOSO

TVP / EMBOLIA PULMONAR

DE LA SOSPECHA AL MANEJO OPORTUNO



1 RECONOCER

SOSPECHE TVP

- Edema unilateral de extremidad
- Dolor o sensibilidad
- Aumento de temperatura
- Eritema o cambio de coloración
- Factores de riesgo: inmovilización, cirugía reciente, hospitalización, cáncer, embarazo, traumatismo o antecedente de Tromboembolismo Venoso (TEV).

SOSPECHE EMBOLIA PULMONAR

- Disnea de inicio súbito
- Dolor torácico (especialmente pleurítico)
- Taquicardia
- Síncope, presíncope o mareo
- Tos + hemoptisis
- Hipoxemia
- Signos de TVP asociados

2 CLASIFICAR EL RIESGO (prioridad de atención)

REFERIMIENTO INMEDIATO

EP con compromiso hemodinámico/ cardiopulmonar

- Hipotensión persistente o recurrente
- Shock
- Hipoxemia/falla respiratoria grave
- Deterioro clínico
- Paro cardiorrespiratorio

EVALUACIÓN EL MISMO DIA

Sospecha de EP hemodinámicamente estable o TVP proximal sintomática

- Disnea/dolor torácico
- Taquicardia
- Hipoxemia
- TVP sintomática (USG no disponible)

CONSULTA PRIORITARIA

Síntomas venosos compatibles con TVP, sin datos de EP ni compromiso hemodinámico

- Edema y dolor unilateral
- Factores de riesgo presentes
- Estable clínicamente

SEGUIMIENTO AMBULATORIO

TEV diagnosticado y en tratamiento

- Clínicamente estable
- Con anticoagulación
- Sin datos de alarma

3 ACTUAR (estudio diagnóstico)

SOSPECHE TVP

Probabilidad clínica → Dímero D (según corresponda) → Ultrasonido venoso

SOSPECHA DE EP

Probabilidad clínica → Dímero D (según corresponda) → Angio-TC pulmonar

Paciente inestable + alta sospecha de EP → active manejo de emergencia y ruta vascular sin retrasos evitables.

4 TRATAR / REFERIR

TEV CONFIRMADO

Anticoagulación salvo contraindicación

- Anticoagulantes orales directos (DOAC) sobre antagonistas de vitamina K (cuando sea candidato).
- Si se requiere anticoagulación parenteral inicial, preferir HBPM sobre heparina no fraccionada.

EP DE ALTO RIESGO / DETERIORO

- Activar equipo y ruta especializada.
- Valorar terapia avanzada en centros con experiencia:
  - Trombólisis sistémica
  - Trombólisis dirigida por catéter
  - Trombectomía mecánica
  - Embolectomía quirúrgica

5 DAR SEGUIMIENTO

Después de una EP

- Confirmar duración y adherencia a anticoagulación.
- Evaluar riesgo de recurrencia y sangrado.
- Reevaluar síntomas y capacidad funcional.
- Disnea persistente → investigar secuelas tromboembólicas (enfermedad pulmonar tromboembólica crónica).

Factores clave

- Identificar y tratar factores de riesgo.
- Educar sobre signos de alarma.
- Coordinar seguimiento con especialidad.
- Individualizar duración del tratamiento.
- Vigilar complicaciones y recurrencia.

CÓDIGO TROMBOEMBOLISMO VENOSO
TVP / EMBOLIA PULMONAR

CÓDIGO AÓRTICO

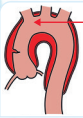
SÍNDROME AÓRTICO AGUDO

DE LA SOSPECHA AL MANEJO OPORTUNO





SÍNDROME AÓRTICO AGUDO
incluye:
- Disección aórtica
- Hematoma intramural
- Úlcera aórtica penetrante



STANFORD A
Aorta ascendente involucrada



STANFORD B
Aorta ascendente no involucrada

1 RECONOCER

SOSPECHE SÍNDROME AÓRTICO AGUDO

- Dolor torácico, dorsal o abdominal de inicio súbito e intensidad máxima
- Dolor migratorio o de carácter desgarrante
- Diferencia de pulso o presión arterial entre extremidades
- Síncope
- Déficit neurológico agudo
- Isquemia de extremidad
- Signos de hipoperfusión/ /malperfusión de órganos
- Hipotensión o shock

ALTO RIESGO
- Aneurisma/aortopatía conocida
- Válvula aórtica bicúspide
- Síndrome de Marfan u otra aortopatía hereditaria
- Antecedente familiar de enfermedad aórtica

2 CLASIFICAR EL RIESGO (prioridad de atención)

REFERIMIENTO INMEDIATO
Sospecha o diagnóstico de síndrome aórtico agudo
- Hipotensión o shock
- Déficit neurológico
- Isquemia de órgano o extremidad
- Dolor persistente/recurrente
- Signos de ruptura o taponamiento

→ ACTIVE CÓDIGO AÓRTICO

EVALUACIÓN EL MISMO DIA
Síntomas o hallazgos sugestivos de enfermedad aórtica sin criterios suficientes de síndrome aórtico agudo, pero que requieren valoración urgente especializada.

CONSULTA PRIORITARIA
Aortopatía/aneurisma conocido estable que requiere evaluación especializada según diámetro, crecimiento y factores de riesgo.

SEGUIMIENTO AMBULATORIO
Enfermedad aórtica estable con vigilancia clínica e imagenológica ya establecida.

3 ACTUAR (estudio diagnóstico inicial)

Sospecha clínica → Monitorización + 2 accesos IV + analgesia → **Angio-TC de aorta** (si está disponible y el paciente lo permite) → Definir anatomía y extensión → Contactar centro/equipo aórtico

CONTROL ANTIIMPULSO
Reducir la tensión de la pared aórtica

Frecuencia cardiaca objetivo: **60 - 80 lpm**
Presión arterial sistólica: **< 120 mmHg** o la presión más baja que mantenga perfusión adecuada.

4 TRATAR / REFERIR

STANFORD A (Aorta ascendente involucrada)



CIRUGÍA URGENTE
- Contactar cirugía cardiovascular / centro aórtico.
- Transferencia inmediata cuando proceda.

STANFORD B (Aorta ascendente no involucrada)



NO COMPLICADA
- Manejo médico inicial (control antiimpulso).
- Vigilancia estrecha en centro especializado.

COMPLICADA INTERVENCIÓN URGENTE
- Ruptura
- Malperfusión/oclusión de ramas
- Extensión o crecimiento progresivo
- Dolor intratable
- Hipertensión no controlada

5 TRATAR / REFERIR

Después de un síndrome aórtico agudo
- Control estricto de presión arterial.
- Betabloqueo a largo plazo cuando esté indicado.
- Vigilancia de aorta residual
- Adherencia y educación sobre síntomas de alarma.
- Seguimiento por equipo especializado.

Imagen de seguimiento (TC o RM)

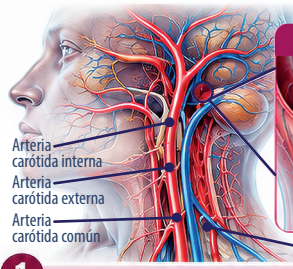
1 mes → 6 meses → 12 meses → Anual (si estable)

CÓDIGO AÓRTICO
SÍNDROME AÓRTICO AGUDO

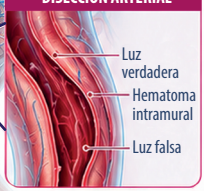
CÓDIGO CABEZA Y CUELLO

URGENCIAS VASCULARES DE CABEZA Y CUELLO

DE LA SOSPECHA AL MANEJO OPORTUNO



DISECCIÓN ARTERIAL



PATOLOGÍA VASCULAR CERVICAL INCLUYE:

- Disección carotídea
- Disección vertebral
- Estenosis carotídea sintomática
- Otras causas de isquemia cervical (p. ej. oclusión)

1 RECONOCER

SOSPECHE PATOLOGÍA VASCULAR CERVICAL

- Cefalea nueva o intensa, especialmente unilateral
- Dolor cervical de aparición reciente
- Dolor facial u orbitario
- Síndrome de Horner parcial (ptosis + miosis)
- Tinnitus pulsátil
- Déficit de pares craneales
- Síntomas neurológicos focales o AIT/EVC
- Antecedente de traumatismo o manipulación cervical reciente

PIENSE EN DISECCIÓN

Dolor cervical/cefalea + Horner o déficit neurológico = imagen vascular urgente

2 CLASIFICAR EL RIESGO (prioridad de atención)

REFERIMIENTO INMEDIATO

Sospecha de disección carotídea/vertebral con:

- Déficit neurológico agudo
- AIT/EVC
- Alteración del estado de conciencia
- Signos de isquemia cerebral o medular

→ ACTIVE CÓDIGO CEREBROVASCULAR

EVALUACIÓN EL MISMO DIA

- Cefalea/dolor cervical nuevo + Horner parcial
- Tinnitus pulsátil de nueva aparición con sospecha vascular
- Dolor cervical/cefalea tras traumatismo con signos sugestivos
- Déficit de par craneal acompañado de dolor cervical/facial

CONSULTA PRIORITARIA

Enfermedad carotídea/vertebral conocida, clínicamente estable, que requiere estratificación especializada.

SEGUIMIENTO AMBULATORIO

Patología vascular cervical diagnosticada y estable, bajo tratamiento y vigilancia establecidos.

3 ACTUAR (estudio diagnóstico inicial)

Sospecha clínica → Exploración neurológica + pulsos cervicales/periféricos + PA → **Angio-TC** de cabeza y cuello **RM + Angio-RM** (según disponibilidad si el paciente lo permite) → Identificar disección / estenosis / oclusión → Neurología Neurointervencionismo Cirugía vascular según hallazgos

4 TRATAR / REFERIR

DISECCIÓN CERVICAL (sin EVC agudo)



- Tratamiento antitrombótico individualizado.
- Valoración por neurología o cirugía vascular.
- Vigilancia clínica e imagenológica.
- Usualmente 3 - 6 meses de tratamiento antitrombótico (según evolución).

CON EVC ISQUÉMICO AGUDO



ACTIVE CÓDIGO CEREBROVASCULAR

La presencia de disección no excluye por sí misma trombólisis IV o trombectomía mecánica en pacientes que por lo demás sean elegibles.

5 DAR SEGUIMIENTO

Después de un síndrome aórtico agudo

- Control estricto de presión arterial.
- Betabloqueo a largo plazo cuando esté indicado.
- Vigilancia de aorta residual
- Adherencia y educación sobre síntomas de alarma.
- Seguimiento por equipo especializado.

Imagen de seguimiento (TC o RM)

3 - 6 meses → 12 meses → Anual (si estable)

© 2026 Adelpi Healthcare de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.

CÓDIGO CABEZA Y CUELLO
URGENCIAS VASCULARES DE CABEZA Y CUELLO